

Schizophrenie

Definition:

Psychische Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis, gekennzeichnet durch eine Vielfalt produktiver (Positiv-) und nicht-produktiver (Negativ-)Symptome wie Wahn, Halluzinationen, Ich-Störungen, Denkstörungen sowie Affektverflachung und sozialen Rückzug. Die Ätiopathogenese ist multifaktoriell und bis heute nicht abschließend geklärt. Verschiedene diagnostische Unterformen werden nach ICD-10 unterschieden. Behandlungsziel ist ein von der Symptomatik weitgehend unabhängiges Leben in Selbstbestimmung (Recovery).

Epidemiologie:

- **Lebenszeitprävalenz:** Weltweit ca. 1%; bei familiärer Belastung deutlich erhöht
 - Kinder erkrankter Eltern: 12%
 - Eineiige Zwillinge: Ca. 46%; zweieiige Zwillinge: Ca. 14%; Geschwister: Ca. 10%
- **Jahresinzidenz:** Weltweit 15/100.000 Personen; leicht erhöht in städtischen Regionen
- **Erkrankungsbeginn:** Meist zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr; bei Männern durchschnittlich 3–4 Jahre früher als bei Frauen
- **Zweiter Erkrankungsgipfel** postmenopausal bei Frauen
- **Lebenszeitrisiko:** ■ ≈ ■

Ätiologie:

Die Schizophrenie ist am ehesten multifaktoriell bedingt. Genetische, neurobiologische und psychosoziale Faktoren wirken im Rahmen des **Vulnerabilitäts-Stress-Modells** zusammen.

- **Genetische Faktoren:**
 - Große Rolle der Erbllichkeit, jedoch nicht als alleiniger Faktor
 - Vermutlich polygener Erbgang mit über 100 identifizierten Risikogenen
 - Risikofaktor: Hohes paternales Alter
- **Umweltassoziierte Faktoren:**
 - Prä-, peri- und postnatale Hirnschädigungen (Infektionen der Mutter, Geburtskomplikationen)
 - Saisonale Faktoren: Gehäuftes Auftreten bei Wintergeburten
 - Noxen im Kinder-/Jugendalter: Amphetamin- und Cannabiskonsum
 - Psychosoziale Stressoren: Elterntrennung, Urbanisation, Migration, High Expressed Emotions, Missbrauch/Misshandlung
 - Sozialstatus: Häufiger in sozial benachteiligten Schichten
- **Neurobiologische Faktoren:**
 - **Dopaminhypothese:** Dysregulation des Dopaminstoffwechsels mit Hyperaktivität im limbischen System und Hypoaktivität im Frontalhirn; gestützt durch Wirkung von D2-Antagonisten und dopaminergen Stimulanzien
 - **Glutamathypothese:** Unterfunktion von NMDA-Rezeptoren, insb. frontal; gestützt durch psychoseinduzierende Wirkung von NMDA-Antagonisten (Phencyclidin, Ketamin)
 - **Serotonin:** Psychoseauslösung durch serotonerge Halluzinogene (Psilocybin, LSD); atypische Antipsychotika blockieren 5-HT₂-Rezeptoren
 - **Strukturelle Veränderungen:** Verminderung grauer Substanz, Vergrößerung der Seitenventrikel, Hypofrontalität, fronto-temporo-limbische Netzwerkstörung (Diskonnektivitätshypothese)
- **Pathophysiologische Modelle:**
 - **Vulnerabilitäts-Stress-Modell (Zubin & Spring):** Erhöhte neuropsychologische Anfälligkeit + endogene/exogene Stressoren → Manifestation
 - **Vulnerabilitäts-Stress-Coping-Modell (Nuechterlein):** Unzureichendes Coping in Stresssituationen führt zu psychotischer Symptomatik

- **Multiple-Hit-Modell:** Genetische Prädisposition (First Hit) + mehrere pathogene Umweltfaktoren → Ausbruch

Prognose:

- **Verlaufsformen:** Individuelle Verläufe nicht vorhersagbar
 - 20% Vollremission nach erster Episode ohne späteres Rezidiv
 - Ca. 2/3 episodischer Verlauf (mit vollständiger oder teilweiser Remission)
 - 5–10% chronisch progredienter Verlauf
- **Lebenserwartung:** Ca. 15 Jahre kürzer als Gesamtbevölkerung; Mortalität 2,6-fach erhöht
- **Günstige Prognosefaktoren:** Weibliches Geschlecht, verheiratet, akuter Krankheitsbeginn, kurze Dauer der unbehandelten Psychose (DUP), soziale Integration, seltenere/kürzere Episoden
- **Ungünstige Prognosefaktoren:** Männliches Geschlecht, alleinstehend, schleichender Beginn, initiale Negativsymptomatik, High Expressed Emotions, Cannabismissbrauch, lange DUP

Merke: Suizidalität: 10% der Betroffenen unternehmen innerhalb des ersten Jahres einen Suizidversuch; 5–15% versterben an einem Suizid!

Symptome:

- **Positivsymptomatik** (insb. in akuten Phasen – produktive Symptome):
 - Wahn: Verfolgungswahn, Beeinträchtigungs- und Beziehungswahn, Wahnwahrnehmungen
 - Halluzinationen: Meist akustisch (kommentierende/dialogisierende Stimmen); seltener optisch, taktil, olfaktorisch
 - Ich-Störungen: Gedankeneingebung, Gedankenentzug, Gedankenausbreitung, Gedankenlautwerden, Fremdbeeinflussungserleben
 - Formale Denkstörungen: Denkzerfahrenheit, Ideenflucht, Gedankenabreißen, Neologismen, Vorbeireden
 - Desorganisiertes, bizarres Verhalten
- **Negativsymptomatik** (insb. in chronischen Phasen – nicht-produktive Symptome, die "6 A"):
- **Einteilung nach K. Schneider:**
 - **Symptome 1. Ranges:** Ich-Störungen mit Fremdbeeinflussungserleben, Wahnwahrnehmungen, kommentierende/dialogisierende Stimmen
 - **Symptome 2. Ranges:** Andere akustische Halluzinationen, Halluzinationen anderer Sinnesmodalitäten, Wahneinfälle, Affektstörungen
- **Weitere Symptome:**
 - Katatone Symptome: Stupor, Mutismus, Katalepsie, Flexibilitas cerea, Negativismus, Echopraxie, katatone Erregung
 - Neuropsychologische Defizite: Aufmerksamkeits-, Gedächtnis- und Exekutivfunktionsstörungen
 - Vegetative Störungen: Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen, gastrointestinale, urologische und kardiale Beschwerden
- **Frühwarnzeichen eines Rezidivs:** Unruhe, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen, sozialer Rückzug, Misstrauen, depressive Verstimmung
- **Komorbiditäten:**
 - Psychisch: Substanzmissbrauch (insb. Cannabis, Alkohol), Angststörungen, PTBS, Zwangsstörungen, Depression
 - Somatisch: Metabolische und kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes mellitus Typ 2, Adipositas, Schlafapnoe, Epilepsie

Merke: Die Negativsymptomatik lässt sich gut mit den 6 "A" merken: Anhedonie, Apathie, Affektverflachung, Aufmerksamkeitsstörungen, Asozialität und Alogie!

Diagnostik:

Diagnostische Kriterien nach ICD-10 (mind. 1 Monat Dauer):

- **Kriterium B – mind. 1 Symptom aus:** Ich-Störungen mit Fremdbeeinflussungserleben; anhaltender bizarrer Wahn; kommentierende/dialogisierende Stimmen
- **oder mind. 2 Symptome aus:** Anhaltende Halluzinationen; Denkzerfahrenheit/Gedankenabreißen/Neologismen; katatone Symptome; Negativsymptome (Apathie, Sprachverarmung, inadäquater Affekt)
- **Kriterium C – Ausschlusskriterien:** Affektive Störung trat zeitlich vor den schizophrenen Kriterien auf; psychotische Störung durch Intoxikation, Entzug oder organische Hirnerkrankung

Diagnostische Unterformen nach ICD-10:

- **Paranoide Schizophrenie (F20.0):** Häufigste Form (65%); Leitsymptome Wahn und akustische Halluzinationen; Beginn 25.–35. Lj.; eher günstigere Prognose
- **Hebephrene Schizophrenie (F20.1):** 15% der Fälle; Leitsymptome Affektverflachung/inadäquater Affekt und Denkzerfahrenheit; Beginn 15.–25. Lj.; ungünstigere Prognose
- **Katatone Schizophrenie (F20.2):** 2–8%; Leitsymptom psychomotorische Störungen (Stupor, Erregung, Katalepsie); eher günstigere Prognose
- **Weitere Formen:** Undifferenzierte Schizophrenie (F20.3), Postschizophrene Depression (F20.4), Schizophrenes Residuum (F20.5), Schizophrenia simplex (F20.6)

Obligate Diagnostik bei Erstmanifestation:

- Psychiatrische Anamnese und psychopathologischer Befund
- Internistische und neurologische Untersuchung inkl. Vitalzeichen
- Routinelabor Diagnostik, Urin-Drogenscreening, EKG
- cMRT zum Ausschluss organischer Ursachen
- Fakultativ: Liquorpunktion, EEG, neuropsychologische Testung bei entsprechendem Verdacht

Merke: Eine psychotische Symptomatik ist nicht primär "psychiatrisch" – eine somatische Genese muss immer ausgeschlossen werden! Ein Medikationscheck ist obligat bei jeder neu aufgetretenen Symptomatik!

Therapie:

Allgemein: Multiprofessionell, mehrdimensional und phasenspezifisch. Partizipative Entscheidungsfindung und Vermeidung von Zwangsmaßnahmen. Behandlung möglichst ambulant und wohnortnah.

Pharmakotherapie – Antipsychotische Therapie:

- Orale Monotherapie in möglichst niedriger Dosierung bevorzugen
- Keine generelle Priorisierung einzelner Substanzen; Orientierung am Nebenwirkungsprofil und Patientenwunsch
- **Besondere Indikationen:**
 - Vorwiegende Negativsymptomatik: Amisulprid (niedrig dosiert) oder Cariprazin
 - Therapieresistenz: Umstellung auf Clozapin (Zielplasmaspiegel mind. 350 ng/mL)
 - Bei Unverträglichkeit/Ablehnung von Clozapin: Olanzapin oder Risperidon
 - Erfolgreiche Monotherapie mit 3 Antipsychotika (inkl. Clozapin): Kombinationstherapie mit 2 Antipsychotika
- **Erhaltungs- und Langzeittherapie:** Kontinuierliche Fortführung in möglichst niedriger Dosierung zur Rezidivprophylaxe; Dosisreduktion langsam und unter engmaschiger Begleitung (Schritte 5–20%)
- **Begleitsymptome:**
 - Erregung/Angst/Unruhe: Lorazepam oral oder parenteral, ggf. + Antipsychotikum
 - Schlafstörungen: Atypisches Antipsychotikum mit sedierender Komponente (Quetiapin, Olanzapin)
 - Depression: Antipsychotikum mit antidepressiver Komponente (Quetiapin), ggf. + Antidepressivum
 - Akute Suizidalität: Benzodiazepin; bei anhaltender Suizidalität: Clozapin erwägen

Psychotherapie und psychosoziale Verfahren:

- **Psychoedukation:** Wesentlicher Bestandteil in allen Phasen; Einbeziehung von Angehörigen
- **Kognitive Verhaltenstherapie (KVT):** Für alle Betroffenen; mind. 16 Sitzungen; auch bei erhöhtem Psychoserisiko; kognitive Umstrukturierung von Wahnhaltungen und dysfunktionalen Kognitionen

- **Metakognitives Training (MKT):** Reduktion von Positivsymptomatik; Einzel- oder Gruppentherapie
- **Familienfokussierte Interventionen:** Für alle Betroffenen und Angehörigen; mind. 10 Sitzungen über 3 Monate bis 1 Jahr; senkt Rezidivrate signifikant
- **Soziales Kompetenztraining:** Bei relevanten Defiziten und Negativsymptomatik
- **Kognitive Remediation:** Bei kognitiven Defiziten; fördert berufliche/soziale Wiedereingliederung
- **Traumafokussierte Interventionen:** Bei komorbider PTBS (Prolongierte Exposition, EMDR)
- **Weitere Verfahren:** Ergotherapie, Sport- und Bewegungstherapie, Musiktherapie, Soziotherapie, achtsamkeitsbasierte Verfahren

Nicht-invasive Stimulationsverfahren:

- **EKT:** Bei perniziöser Katatonie (1. Wahl), schwerer Depression mit Suizidalität, Therapieresistenz
- **rTMS:** Bei medikamentöser Therapieresistenz; niederfrequent (1 Hz) links temporal bei akustischen Halluzinationen; hochfrequent (10/20 Hz) links dorsolateral-präfrontal bei Negativsymptomatik

Behandlung nach Krankheitsphase:

- **Stadium des erhöhten Psychoserisikos:** KVT, psychosoziale Maßnahmen, Substanzscreening; Ziel: Prävention/Verzögerung der Psychose
- **Frühphase (Erstmanifestation):** Intensive Pharmako-, Psycho- und Soziotherapie; DUP möglichst kurz halten; Dauer 3–5 Jahre
- **Akutphase:** Symptomlinderung, Beziehungsaufbau, Psychoedukation; bevorzugt ambulant; Dauer Wochen bis 3 Monate
- **Postakute Stabilisierungsphase:** Therapiestabilisierung, Negativsymptombehandlung, Rückfallfrüherkennung; Dauer 3–6 Monate
- **Remissionsphase:** Rezidivprophylaxe, Lebensqualität, soziale Wiedereingliederung; Dauer Monate bis Jahre

Merke: Zusammengefasst empfehlen sich eine frühzeitige medikamentöse Akutbehandlung, eine konsequente Rückfallprophylaxe, Psycho- und Soziotherapie sowie die soziale Wiedereingliederung!